

Pestaña 1

Hidradenitis Suppurativa

1. Introducción y relevancia clínica

La **hidradenitis suppurativa (HS)** —también conocida como **acné inverso**— es una **enfermedad inflamatoria crónica y recidivante de la unidad pilosebácea** que afecta principalmente las **zonas intertriginosas** (axilas, ingles, región perineal, glútea y submamaria).

Se caracteriza por la aparición de **nódulos dolorosos, abscesos profundos, trayectos fistulosos y cicatrices retráctiles**, con impacto físico, psicológico y social considerable.

Relevancia clínica

- Afecta entre 1% y 4% de la población general.
 - Mayor prevalencia en **mujeres jóvenes (20–40 años)** y pacientes con **obesidad o tabaquismo**.
 - Su **diagnóstico precoz y tratamiento adecuado** pueden evitar secuelas cicatriciales graves.
 - En EUNACOM, suele evaluarse el **reconocimiento clínico**, la **clasificación de Hurley** y el **uso escalonado del tratamiento médico y quirúrgico**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo fisiopatológico

La HS se origina en la **oclusión del folículo pilosebáceo**, seguida de:

1. **Ruptura folicular** → liberación de queratina y bacterias al tejido circundante.
2. **Inflamación intensa** con infiltrado neutrofílico y linfocitario.
3. **Formación de abscesos y trayectos fistulosos crónicos**.
4. **Fibrosis y cicatrización progresiva**.

Actualmente se entiende como una **enfermedad inflamatoria autoinflamatoria** más que infecciosa, donde predominan citocinas como **TNF- α , IL-1 β , IL-17 e IL-23**.

2.2. Factores predisponentes

- **Genéticos:** hasta 40% tiene antecedentes familiares.
 - **Hormonales:** andrógenos aumentan la secreción sebácea y queratinización.
 - **Ambientales:**
 - **Tabaquismo (90% de los casos).**
 - **Obesidad** (fricción, hiperhidrosis, maceración).
 - **Estrés y calor** como desencadenantes.
 - **Asociaciones sistémicas:** enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn), síndrome metabólico, espondiloartritis.
-

2.3. Clasificación anatomo-clínica: Hurley (1975)

Estadio	Características clínicas	Implicancia terapéutica
I (leve)	Nódulos o abscesos aislados, sin fístulas ni cicatrices	Tratamiento médico
II (moderado)	Reurrencias con trayectos fistulosos limitados	Médico + quirúrgico local
III (severo)	Múltiples fístulas interconectadas, cicatrices extensas	Cirugía radical $\pm$ biológicos

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas

a. Lesiones iniciales

- Nódulos subcutáneos dolorosos y firmes (“granos profundos”).
- Evolucionan a abscesos fluctuantes que drenan material purulento maloliente.
- Lesiones tienden a **reaparecer en los mismos sitios**.

b. Lesiones crónicas

- Trayectos fistulosos con múltiples orificios de drenaje.
- Cicatrices deprimidas o fibrosas, tipo “cuerda”.
- Hiperpigmentación o disfiguración local.

c. Localización típica

- Axilas (más común).
 - Ingles y periné.
 - Región glútea e interglútea.
 - Submamaria (en mujeres).
 - Cuello posterior o abdomen inferior (menos frecuente).
-

3.2. Síntomas acompañantes

- Dolor crónico, sensación de quemazón o presión.
 - Secreción maloliente persistente.
 - Impacto psicológico severo: depresión, ansiedad, aislamiento social.
 - En casos severos: fiebre, malestar general.
-

3.3. Evolución

- Curso **crónico y recidivante**, con períodos de exacerbación y remisión.
 - Cicatrización progresiva que puede causar **limitación funcional** (ej. movilidad axilar).
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Enfermedad	Diferencias clave
Furunculosis	Lesiones aisladas, no recidivantes, sin fístulas
Abscesos por MRSA	Unifocales, sin patrón simétrico
Quistes epidermoides infectados	Sin trayectos fistulosos
Acné conglobata	En espalda o pecho, no en áreas intertriginosas
Enfermedad de Crohn perianal	Fístulas profundas, asociadas a diarrea crónica

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

La HS es un diagnóstico **clínico**, basado en los **tres criterios de consenso internacionales**:

1. Lesiones típicas: nódulos, abscesos, trayectos fistulosos y cicatrices.
2. Localización típica: axilas, ingles, región perianal, submamaria.
3. Curso crónico y recurrente (>2 episodios en 6 meses).

Cumplir los tres criterios confirma el diagnóstico.

4.2. Exámenes complementarios

- **Cultivo bacteriano:** solo si sospecha de sobreinfección secundaria.
 - **Ecografía de partes blandas:** delimita trayectos fistulosos.
 - **PCR y leucocitos:** si fiebre o signos de sepsis.
 - **Screening metabólico:** glicemia, perfil lipídico, IMC.
 - **Biopsia:** si duda diagnóstica (descartar carcinoma epidermoide).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile, 2023)

El manejo debe ser **escalonado, prolongado y multidisciplinario**, combinando medidas generales, farmacológicas y quirúrgicas.

5.1. Medidas generales

- **Suspender tabaco.**
 - **Control del peso** (IMC < 25 mejora pronóstico).
 - **Evitar ropa ajustada y depilación mecánica.**
 - **Higiene diaria con antisépticos** (clorhexidina o jabón de azufre).
 - **Compresas tibias o baños de asiento.**
 - **Soporte psicológico y educación del paciente.**
-

5.2. Tratamiento médico

A. Formas leves (Hurley I)

- **Antibióticos tópicos:** clindamicina 1% gel, 2 veces al día por 12 semanas.
 - **Antisépticos:** clorhexidina 4%, povidona yodada.
 - **Antiinflamatorios tópicos:** resorcinol al 15% (en centros especializados).
 - **Dolor:** AINEs o paracetamol.
-

B. Formas moderadas (Hurley II)

- **Antibióticos sistémicos (primera línea):**
 - Doxiciclina 100 mg/día o minociclina 100 mg/día por 3 meses.
 - Alternativas: clindamicina 300 mg + rifampicina 300 mg cada 12 h por 10 semanas.
 - Eficacia: 70–80% de remisión parcial.
 - **Terapia hormonal (en mujeres):**
 - Anticonceptivos orales combinados (etinilestradiol + drospirenona).
 - Espironolactona (50–100 mg/día).
 - **Retinoides orales (isotretinoína o acitretina):**
 - Útiles solo en cuadros leves-moderados o con acné asociado.
-

C. Formas severas (Hurley III o refractarias)

- **Corticoides sistémicos:**
 - Prednisona 0,5–1 mg/kg/día por 1–2 semanas en brotes agudos.
 - Pulsos de metilprednisolona IV si abscesos múltiples inflamatorios.
- **Biológicos (según MINSAL y EMA 2023):**
 - **Adalimumab** (anti-TNF- α):
 - Dosis: 160 mg SC día 1, 80 mg día 15, luego 40 mg/semana.

- Mejora significativa en 12–16 semanas.
- Alternativas: infliximab, secukinumab, ustekinumab (casos seleccionados).
- **Antibióticos de rescate:** moxifloxacino, metronidazol o ertapenem (fase supurativa severa hospitalaria).

5.3. Tratamiento quirúrgico

Procedimiento	Indicaciones	Descripción
Drenaje simple	Absceso agudo	Alivia dolor, pero alta recurrencia
Destechamiento (deroofing)	Trayectos aislados	Eliminación del techo del trayecto fistuloso
Escisión amplia	Hurley III	Resección completa hasta tejido sano
Injertos o colgajos	Reconstrucción postresección	En centros especializados

MINSAL sugiere derivación a cirugía dermatológica en Hurley II–III o fracaso médico.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Infección secundaria	Staphylococcus aureus o anaerobios
Linfedema local	Por fibrosis y destrucción linfática

Cicatrices retráctiles o disfiguración Especialmente axilar o genital

Anemia y desnutrición En formas supurativas crónicas

Carcinoma epidermoide cutáneo Riesgo en lesiones perineales crónicas (1–3%)

Impacto psicológico severo Depresión y ansiedad frecuentes

Pronóstico:

- Enfermedad crónica con tendencia a recidivas.
- 30% entra en remisión prolongada con tratamiento combinado.
- Mejor pronóstico con intervención temprana, control de peso y abstinencia tabáquica.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Zonas intertriginosas, abscesos recurrentes, fístulas y cicatrices** → pensar en hidradenitis supurativa.
2. **Tabaquismo y obesidad** son los factores modificables más importantes.
3. **Antibióticos prolongados (doxiciclina o clindamicina + rifampicina)** son el tratamiento de elección inicial.
4. **Adalimumab** es el biológico aprobado de primera línea en casos refractarios.
5. El **tratamiento quirúrgico radical** es la única opción curativa en estadios avanzados.

6. En EUNACOM, las preguntas destacan **la clasificación de Hurley y el manejo escalonado** (tópico → sistémico → biológico → quirúrgico).
-



Errores comunes

- Tratar como foliculitis o absceso aislado sin reconocer cronicidad.
 - No suspender el tabaco o no manejar la obesidad.
 - Usar antibióticos por períodos muy cortos (<4 semanas).
 - No derivar a dermatología en Hurley II–III.
 - Omitir el soporte psicológico o el manejo del dolor.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hidradenitis supurativa** es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea que afecta **zonas intertriginosas**.
2. Se caracteriza por **nódulos dolorosos, abscesos, trayectos fistulosos y cicatrices**.
3. El **diagnóstico es clínico** (lesiones típicas + localización + recurrencia).
4. El tratamiento se basa en **cambio de hábitos, antibióticos prolongados, y biológicos (adalimumab)** en casos severos.
5. La **clasificación de Hurley** orienta la terapia y pronóstico.
6. El **control del tabaco y peso corporal** mejora significativamente la evolución.
7. En EUNACOM, la clave es reconocer el **patrón crónico y topografía típica** de la HS, diferenciándola de abscesos comunes.